# 7.2.1. 위험관리체계

| 제 정 일 | 2014.04 | 최 종 개 정 일 | 2025.03.25. | 최 종 검 토 일 | 2025.03.25. |
|---|---|---|---|---|---|
| 담 당 부 서 | 의료질향상 및 환자안전위원회, 감염관리위원회, 시설안전관리위원회, 재난대응 위원회 | | | | |
| 유 관 부 서 | | | | | |

| 관 련 기 준 | 4주기 의료기관인증기준: 7.2 위험관리체계<br>JCI Standard 7th Edition: QPS.10 |
|---|---|

제1조 (목적)

1. 예기치 않은 위해 사건과 본원 모든 구성원에게 미치는 잠재적인 위험 또는 위험 가능성을 없애거나 감소시키기 위해 의료기관 차원의 위험요인을 파악하여 환자와 직원의 안전을 확보하기 위한 적절한 체계를 구축하고 원인분석 및 개선활동을 효율적으로 수행 및 관리하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 위험관리: 의료서비스 중 발생할 수 있는 위험상황이나 사고를 발생초기에 파악 조정하고, 위험 발생 가능성에 대한 사전 관리를 통해 경제적, 정신적 손실로부터 환자, 의료진 및 의료기관을 보호하며 적정한 진료를 제공하도록 하는 의료서비스의 질향상 활동

제3조 (절차)

1. 위험관리 영역 및 위험관리 조직
   1) 병원차원의 위험관리 영역은 환자안전, 감염관리, 시설안전, 재난으로 선정하여 관리한다.
   2) 위험관리 활동 관리는 각 영역별로 담당 부서와 관련 위원회가 수행하며 상세한 조직 운영은 아래와 같다.
      (1) 환자안전: 환자안전파트, 의료질향상 및 환자안전위원회
      (2) 감염관리: 감염관리실, 감염관리위원회
      (3) 시설안전: 시설관리팀, 사무팀, 시설안전관리위원회
      (4) 재난: 재난대응위원회

2. 위험요인 확인
   1) 환자안전
      (1) 위험요인 파악: 다음의 항목을 반영하여 주기적으로 위험요소를 확인한다.
         ① 전략 및 사업계획 분석
         ② 내규 및 절차 분석
         ③ 평가항목 및 조사문항
         ④ 근접오류 및 환자안전 보고
         ⑤ 고위험 절차
         ⑥ 지표 모니터링

⑦ 내·외부 고객 제안 및 민원

⑧ 현장모니터링

(2) 확인된 위험요인을 환자안전사고 분류 항목(표1) 및 환자안전사고 결과에 따라 적신호사건, 유해사건, 무해사건, 근접오류로 분류하고, 위험요인에 대하여 사고 보고자 및 의무기록 검토, 해당 시설 및 장비 검토, 진료적 절차 및 소견 등 위험요인 확인 및 분석을 한다.

| (표 1) 세브란스병원 환자안전사고 분류 항목 | |
|---|---|
| 검사 | 처치시술 |
| 마취/진정 | 낙상 |
| 수술 | 의료장비기구/진료재료 |
| 수혈 | 탈원/실종/유괴 |
| 약물 | 환자의 자살자해 |
| 피부손상 | 기타(분만, 감염, 화상, 상해, 식사영양, 행정, 정신과적 응급상황, 심정지, 진단오류, 진단지연) |

2) 감염관리

(1) 손위생과 같은 기본 예방 활동, 환자에게 영향을 주는 감염위험요인, 직원에게 영향을 주는 감염위험요인 감시 자료 및 모니터링 자료 등을 통해 확인한다.

3) 시설안전

(1) 시설안전관리위원회 주관의 시설안전 관련 8개 영역(안전, 보안, 위험물질, 재난, 소방, 의료기기, 유틸리티시스템, 건축 및 보수)의 지표 모니터링 및 시설 점검 등을 통해 상시 감시하여 확인한다.

4) 재난

(1) 병원 내부에서 교직원 및 환자에게 해를 끼칠 수 있는 위기상황이 될 수 있는 사고나 근접 오류 사항들에 대해 관련 위원회 또는 관련 부서의 모니터링을 통해 상시 감시한다.

(2) 지역사회 발생하여 병원에 영향을 끼칠 수 있는 재난유형을 상시로 모니터링하여 위험요인을 확인한다.

3. 위험요인 평가 영역 및 우선순위 선정

1) 환자안전

(1) 각 위험요소에 대해 원인을 파악하고, 심각성과 발생가능성을 정량화하는 [부록1. 위험등록부(Risk Register)]를 작성하여, 위험도 결과에 따라 개선 영역의 우선순위를 선정한다.

(2) 의료질향상 및 환자안전위원회는 환자와 직원의 안전과 환자 진료의 질에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 위험요소 우선순위에 따라 매년 1개 이상의 전향적 위험관리를 시행하며, 분석결과에 따라 위험프로세스를 재설계한다.

2) 감염관리

(1) 매년 위험요인을 분석하고, 감염관리 프로그램의 우선순위는 병원의 미션 및 비전에 부합하는 것으로, 감염의 위험성, 중재가능성, 비용효과성을 고려하며, 의료기관 평가 기준을 고려하여 선정한다.

3) 시설안전

(1) 시설 안전 관련 8가지 영역(안전, 보안, 위험물질, 재난, 소방, 의료기기, 유틸리티시스템, 건축 및 보수)을 모두 통합하는 시설 전반의 위험도 평가는 [부록4. HVA(Hazard Vulnerability Analysis)]를 이용하여 년 1회 시행하여 개선할 우선순위를 선정하고 연 계획에 반영한다.

4) 재난

(1) 지역사회 및 병원내부에서 발생할 수 있는 재난의 위험성을 평가하기 위하여 연간 HVA(Hazard Vulnerability Analysis)를 이용하여 재난 상황의 우선순위를 선정한다.

(2) HVA는 모든 잠재적 발생 가능성이 있는 상황에 대하여 발생 가능성, 위험도, 준비 정도에 대하여 각 상황 별 점수를 매기고 그 총점이 높은 순위별로 우선순위를 선정하는 방식으로 이루어진다.

4. 위험요인 분석 및 개선 활동

1) 환자안전: 의료질향상 및 환자안전위원회에서 우선순위에 따라 위험 관리를 위한 개선 활동으로 전향적 위험 관리와 후향적 위험 관리의 방법으로 개선 활동을 수행한다.

(1) 전향적 위험관리(Proactive Risk Management): 발생 가능한 사건의 결과를 전향적으로 분석하여 분석결과에 따라 위험프로세스 재설계하는 방식의 실패 유형 영향분석(Failure Mode and Effect Analysis) 을 통해 개선 활동 수행한다. [부록2. FMEA(Failure Mode and Effect Analysis) Methodology]

(2) 후향적 위험관리(Reactive Risk Management): 위해 사건은 사안별 원인분석을 통한 개선활동을 수행하고, 모든 적신호 사건에 대해서 근본원인분석을 실시하고 개선활동을 수행한다.

2) 감염관리

(1) 감염위험평가를 통해 우선순위로 선정된 위험 항목은 해당 년도 감염관리 프로그램에 반영하여 중재안을 마련하여 관련 부서들과 함께 QI과정을 통해 개선활동을 수행한다.

3) 시설안전

(1) 위험도 평가 결과 우선순위로 결정된 요인을 개선하기 위해 시설안전 개선활동을 수행한다.

4) 재난

(1) 재난 위험도 평가 결과에 따라 취약한 재난 유형에 대처하고자 재난 훈련 주제를 선정하고 재난 훈련을 연 1회 시행한다.

5. 개선 활동 효과의 모니터링 및 평가

1) 환자안전

(1) 실패 유형 및 영향 분석(FMEA)의 경우 개선 활동 전후 효과 평가를 시행한다.

(2) 위해 사건에 대한 사안별 개선 활동 전후 효과 평가를 시행한다.

(3) 근본원인분석(RCA)의 경우 개선활동에 대한 지표를 선정하여 모니터링 한다.

(4) 개선 활동이 종료된 후 잠재적 위험수준을 재평가하여 위험요소를 확인하고 필요한 개선 활동을 수행한다.

(5) 그 결과를 의료질향상 및 환자안전위원회, 병원운영위원회에 보고한다.

2) 감염관리

(1) 우선순위로 선정된 지표를 모니터링하고 감염관리위원회, 의료질향상 및 환자안전위원회, 병원운영위원회 및 관련 위원회에 지표 및 개선활동 결과를 보고한다.

3) 시설안전

(1) 각 분야의 지표를 모니터링하여 지표 및 개선 활동 수행 정도와 결과를 파악하여 차기 년도 계획에 반영하고, 시설안전관리위원회에 보고한다.

4) 재난

(1) 시행한 재난 훈련 및 모니터링 결과를 이용하여 재난대비 계획에 대한 연례 평가를 시행하고, 개선사항은 차기 년도 재난대비 계획 수립에 반영한다.

(2) 그 결과를 시설안전관리위원회, 병원운영위원회에 보고한다.

6. 위험관리 결과 활동 보고 및 관련직원 공유

1) 위험관리 영역의 위험관리 활동 결과는 관련 위원회 및 병원운영위원회에 보고하고 관련 부서와 원내 메일과 게시판을 이용하여 공유한다.

7. 민원 관리

1) 민원 접수 방법

(1) 방문상담: 고객상담실 방문

(2) 전화상담: 02-2228-5105 전화

(3) 인터넷상담: 세브란스병원 홈페이지(고객의 소리)

(4) 내원객 건의함: 건의함 투고

2) 민원 관리 방법

(1) 다음 사항의 경우 환자안전소위원회를 개최한다.

① 예상하지 못한 사망 또는 심각한 주요 기능의 손실을 포함한 경우

② 진료 및 치료의 통상적인 절차로부터 심각하게 벗어난 경우

③ 기타 진료혁신센터에서 논의가 필요하다 판단한 경우

(2) 환자안전소위원회 구성 및 논의사항

① 진료혁신부원장, 환자안전팀, 법무팀으로 구성되며, 소위원회 개최 시 관련 의료진의 참석을 요청한다.

② 사건 발생 원인, 환자 상태, 사건 공개(Disclosure) 여부, 공개의 주체, 합의사항, 사후 진행방향에 대해 논의하며, 사건의 재발방지를 위하여 개선방안을 도출한다.

③ 환자안전소위원회 개최가 요구되지 않은 민원 건에 대해서는 관련 부서의 의견을 참고하여 내부심의 후 회신한다.

④ 환자안전소위원회의 논의 결과는 병원운영위원회에 보고한다.

제4조 (부록)

1. 위험등록부(Risk Register)
2. FMEA(Failure Mode and Effect Analysis) Methodology
3. RCA(Root Cause Analysis) Methodology
4. HVA(Hazard Vulnerability Analysis)

제5조 (참고)

## 내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2014년 4월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)